

EXAMEN DE RESIDENCIAS MEDICAS

CÓRDOBA – 2019

1) Fisura anal: dolor

2) Colelitiasis simple: Vesícula con cálculos: la clínica es asintomática: No se opera

3) Cáncer de colon derecho: Hemicolectomía derecha + ileotransversoanastomosis

4) Cáncer de colon derecho: (ángulo hepático): Unión Ileotransverso

5) Peritonitis bacteriana espontánea:

- Clínica: Fiebre, dolor abdominal, encefalopatía, deterioro del Estado general.
 - Líquido ascítico: Leucocitos > 500, Neutrófilos > 250.
 - Tratamiento: Cefalosporinas de 3^{ra} generación por 5-10 días.
 - Profilaxis: Norfloxacin
-

6) ERCP: Calculo que migró desde vesícula hacia vía biliar.

- Complicaciones: La más frecuente: hemorragia
La más grave: perforación
-

7) Clínica de cólico biliar

8) Oclusión por tumor de colon descendente: si se produce un abdomen agudo oclusivo los ruidos hidroaéreos van a estar aumentados. Rx directa de abdomen: niveles hidroaéreos?

9) Anciano con dolor abdominal alto que irradia a dorso: IAM de Base?. Diseción de aorta (se diagnostica con TAC con contraste).

10) Persona con traumatismo precordial: Diagnóstico: taponamiento cardíaco.

Qué método complementario usaría para diagnosticar el taponamiento cardíaco? Eco fast

11) Rectorragia: cáncer de colon

12) Tumor más frecuente de vía biliar: Klatsking (Porción proximal o superior)

13) Hepatopatía alcohólica: Profilaxis: abandono del alcohol. (GGT aumentada en hepatograma)

14) Colelitiasis: Diagnóstico: ecografía

15) Intoxicación con benzodiazepinas: Lavado gástrico + Carbón Activado (Flumazenil no estaba)

16) Intoxicación con carbamazepina: Intubar!! (porque se produce una alteración de la ventilación mecánica).

17) Líquido pleural con ADA positivo: exudado por tuberculosis

18) Hipoamilasemia:

Pancreatitis Crónica? (Triada: dolor abdominal + DBT + Esteatorrea y malabsorción).

¿La hipoamilasemia se asocia con hipertrigliceridemia?

Causas de Hiperamilasemia:

- Insuficiencia renal
 - Insuficiencia hepática
 - Infarto intestinal
 - Perforación de úlcera
 - Peritonitis
 - Postquirúrgico
 - Patología de: ovario, trompa de Falopio, glándula salival.
-

19) Anemia hemolítica: se produce un aumento de Bilirrubina a predominio Indirecto y de LDH. Se produce destrucción celular, por lo que la anemia es **REGENERATIVA**.

20) Cáncer que produce hipercalcemia:

- **35% Epidermoide de pulmón** (produce un aumento de PTH).
- 25% Mama, riñón y próstata.
- 15% Mieloma múltiple y linfoma.

21) Oat Cell. (Cáncer microcítico de pulmón):

Clínica paraneoplásica:

- ↑ de ADH (hiponatremia)
- ↑ de ACTH (hipopotasemia, síndrome de Cushing)
- Síndrome de Eaton Lambert
- Ceguera retiniana
- Síndrome de vena cava superior

22) Cáncer anaplásico de células grandes:

Clínica paraneoplásica: ginecomastia

23) EPOC y tabaquismo.

24) Niño sano de 18 meses con diarrea autolimitada:

Si es prevalente es secretora por toxinas?

Si es una diarrea que inicia en menos de 6 horas desde la ingesta de comida tengo que pensar en infección por *S. Aureus* (porque ya tiene la toxina pre formada)

25) Causa de Cáncer de cuello de útero: HPV

26) Recién Nacido con APGAR de 8, con cianosis acra y auscultación normal:

Las opciones del choise eran las siguientes:

- a) Cardiopatía
- b) Poliglobulia
- c) *Bebé con frío.* » RESPUESTA CORRECTA « (porque tiene cianosis periférica)

27) A quien se le coloca la vacuna antigripal:

- Embarazo en cualquier trimestre
- Trabajadores de salud
- Niños de 6 meses a 2 años (2 dosis separadas por un mes)
- Menores de 65 años con factores de riesgo
- Mayores de 65 años con o sin factores de riesgo

28) Características de la talasemia:

- Anemia drepanocítica
 - Predomina la Hb F?
 - Anemia de Cooley (Talasemia mayor o beta: es la más grave)
 - Hierro normal o aumentado
 - Ferritina y Transferrina normal
-

29) Síndrome de Cushing: tiene miopatía: debilidad muscular próxima.

30) Disfagia en Cáncer de esófago: es progresiva y comienza con sólidos.

(Nemotecnia: “El Mecánico Organiza”: la disfagia es mecánica y / u orgánica)

31) Dolor epigástrico: úlcera péptica

32) Úlcera duodenal de cara posterior: produce hemorragia por erosión de la Arteria Gastroduodenal.

33) Durante el trabajo de parto cual es la actitud en la que **no** se puede llevar a cabo un parto vaginal: **Cara.** » RESPUESTA CORRECTA «

34) Hormonas en la menopausia: aumento de gonadotrofinas (FSH, LH), disminución de estrógeno y progesterona.

35) EPI: Leucorrea purulenta + DIU:

Dolor anexial

- Criterios mayores:
- Dolor a la movilización del cuello
 - Dolor abdominal bajo
 - Dolor anexial
 - Cervicitis purulenta
-

36) Hiperaldosteronismo: hipernatremia, hipopotasemia, HTA, alcalosis metabólica.

- PRIMARIO: aumenta la aldosterona, disminuye la renina y la angiotensina.
- SECUNDARIO: aumenta la renina, aumenta la angiotensina y la aldosterona.

Recordar: hipopotasemia = alcalosis metabólica

hiperpotasemia = acidosis metabólica

37) Síndrome carcinoide del aparato digestivo: se produce por un aumento de la serotonina.

Clínica: rubor.

Tratamiento: quirúrgico.

38) Talla en un niño de 4 años: 1 metro.

39) Complicación del síndrome nefrótico: **Trombos!**

Recordatorio: Síndrome nefrótico:

- Proteinuria mayor a 3,5
 - Edema con fóvea positivo
 - Hiperlipemia
 - Predisposición a infecciones
 - Hipoalbuminemia
 - Tratamiento de SN: Corticoides
-

40) Síndrome Nefrítico:

Clínica: Hematuria, edemas, hipertensión arterial.

Tratamiento: furosemida + IECA o ARA II

41) Cáncer de mama en mujer mayor:

- Localización más frecuente es el cuadrante superoexterno
 - Si está localizado (menor a 3 cm) el tratamiento es cuadrantectomía más radioterapia
 - Si tiene compromiso ganglionar, realizar vaciamiento
 - Si tiene receptores para estrógenos y progesterona, es de mejor pronóstico
 - El más frecuente es el Ductal Invasor
 - Diagnóstico: Mamografía anual en mayores de 40 años, ecografía, PAAF. (* La mamografía digital mejora la manipulación de la imagen)
-

42) Cáncer de endometrio: el signo más frecuente es la metrorragia.

43) Diagnóstico de cáncer de mama: mamografía.

44) Lactante de 2 – 3 semanas con vómitos blancos en escopetazo, con oliva pilórica + signo de la cuerda. Laboratorio: alcalosis metabólica hipoclorémica.

Diagnóstico: **Estenosis Hipertrófica del Píloro.**

Tratamiento: **Pilorotomía.**

45) Corioamnionitis: inducir el parto por vía más adecuada.? (Cesárea?)

46) Sufrimiento fetal agudo: se representa con líquido meconial.

- DIPS 1: compresión de la cabeza fetal. (Fisiológico)
 - DIPS 2: hipoxia fetal (mayor de 18 seg.) o tardía. Significa que tiene insuficiencia placentaria. (es el de peor pronóstico).
 - DIPS 3: variable o umbilical: significa que tiene compresión del cordón.
-

47) ITU en embarazo: E. coli

48) Cómo se previene la muerte súbita del lactante: lactancia materna, dormirlo de decúbito dorsal!

49) Cuáles son las malformaciones cardíacas en hijo de madre DBT: macrosómicos, TGV, Hipertrofia simétrica del septum, prematuridad, hipoglucemia, hipocalcemia, RCIU, defecto del tubo neural, macro/micro/hidrocefalia, estenosis pilórica, atresia duodenal, hernias. Urogenitales: agenesia renal, hidronefrosis, micropene, criptorquidias, hipospadia. Musculoesquelético: pie varo, labio leporino.

50) Cuando se presenta la DBT pregestacional (que produce las malformaciones cardíacas)

Las opciones del choice eran las siguientes:

- a) **Hiperglucemia en periodo prenatal y primer trimestre.** » RESPUESTA CORRECTA «
- b) Hipoglucemia en primer trimestre
- c) Hiperinsulinemia en primer trimestre

51) Sífilis Congénita:

- AGUDA: Lesiones cutáneas, linfedema, hepatoesplenomegalia, retraso del crecimiento, **rinitis serosanguinolenta** » RESPUESTA CORRECTA «, hidrocefalia, meningitis, convulsiones, osteocondrosis, **pseudoparálisis** » RESPUESTA CORRECTA «, anemia hemolítica.
- CRONICA: tibia en sable, úlceras gomosas, tabes, queratitis intersticial, atrofia óptica, sordera, malformaciones dentales y óseas. (Triada típica: sordera + queratitis + malformaciones dentales.) Se contagia antes del 4to mes.

52) DPPNI: sufrimiento fetal agudo + HTA + hipertono uterino: Cesárea de urgencia!!

53) Exantema súbito es sinónimo de: Virus Herpes 6, Roséola, Sexta Enfermedad.

54) Cefalea en racimos: Cefalea de Horton:

- Mas frecuente en hombres jóvenes
- Es unilateral
- “Ataques sucesivos”
- Se acompaña de: miosis, ptosis, lagrimeo, ojo rojo.
- Tratamiento: O₂ al 100% por 15-30 minutos.
- Tratamiento preventivo: **Verapamilo** » RESPUESTA CORRECTA «, prednisona.
- En pediatría: **Migraña**. » RESPUESTA CORRECTA «

55) Parálisis del 6^{to} par (Motor Ocular Externo): estrabismo convergente

Parálisis del 4^{to} par (Patético): estrabismo convergente

Parálisis del 3^{er} par (Motor Ocular Común): estrabismo divergente + ptosis.

56) **ACV** como causa de hemiparesia.

57) Hematomas:

- Extradural o epidural: es arterial! Se produce entre el cráneo y la duramadre.
Causas: traumatismo craneal por ruptura de Arteria Menígea Media.
En imágenes: Forma de “limon”, desplaza la línea media.
Clínica: al principio se encuentra lucido, luego progresa a deterioro de la consciencia.
- Subdural o subaracnoideo: es venoso? Se produce entre la duramadre y la aracnoides. (es de peor pronóstico). Se lesiona la arteria subaracnoidea.
En imágenes: forma de “banana”, no se desplaza la línea media.
Clínica: deterioro profundo de la consciencia (somnolientos o comatosos desde el momento de la lesión).

58) Retinoblastoma: da leucocoria.

59) Sonrisa social: 2 meses

60) Lactante con falta de crecimiento + fiebre de origen desconocido: realizar urocultivo.
(sospechar ITU).

ITU:

- RN: falta de progreso ponderal inicial, rechazo de alimentación, irritabilidad.
- Lactante: falta de apetito, diarrea, fiebre, aplanamiento de la curva de peso.
- Menor de 2 años: fiebre sin foco.
- Mayor de 2 años: cistitis clásica.

61) Edad de caminar: 12-15 meses.

- 18 meses: sube escaleras con apoyo, arma torres de 2 cubos, usa tenedor.
- 24 meses: sube y baja escaleras con dos pies con ayuda, lanza la pelota, arma torre de 6 cubos.
- 3 años: alterna los pies al bajar las escaleras.

62) 9-10 meses: nena se sienta y con ayuda da pasos.

8 meses: nena que se sienta sin apoyo.

6 meses (trípode): nena que se sienta con apoyo.

63) Nena que pateo la pelota: entre 15 y 20 meses

64) Nena que lanza la pelota: 2 años.

65) Hierro en lactante de 3 meses:

- Prematuro: 2mg/kg/día desde el nacimiento
 - A término: 1 mg/kg/día a partir de los 2 meses
 - A partir del 3 mes: 4mg/kg/día.
 - Hijo de madre anémica: 2 mg desde los 2 meses
 - Formula de suplemento de hierro: Número de mes x 400 + peso al nacer.
-

66) De donde se obtiene la mayor fuente de hierro en un lactante de 3 meses: **lactancia!!**

67) Endometritis: **es la infección puerperal mas frecuente** (complicación tardía de parto)!!

68) ¿Como se contagia la madre embarazada de listeriosis? **Por vía digestiva!!** (carne, frutas, verduras, lácteos mal pasteurizados, quesos blancos y productos de mar).

Clínica: cuadro pseudogripal.

¿Como se contagia el recién nacido?

- Vía transplacentaria: Clínica: granulomatosis infantiseptica (sepsis con cianosis + disnea + hepatoesplenomegalia.
 - Vía por canal de parto: Clínica: meningitis a los 14 días.
-

69) Colpitis con puntos blancos: cándida.

70) Kernicterus: incompatibilidad RH (enfermedad hemolítica del RN)

71) Hipotiroidismo congénito: ictericia persistente

72) Síndrome de Down: se da por trisomía del par 21 (cariotipo 21)

Cardiopatía congénita: CAI, CIV, canal AV completo.

73) DBT Mellitus:

- Glucemia en ayunas > a 100 mg/dl (x2) = Dx
- Glucemia en ayunas > a 126 mg/dl + síntomas (poliuria, polidipsia, polifagia), (x1) = Dx
- Complicaciones: gastroparesia y polineuropatía distal.

74) Test del sudor (fibrosis quística):

- Menor de 30 mmol/L: normal (descarta)
- 30 – 60 mmol/L: posible o intermedio. Repetir la prueba o realizar prueba de ADN.
- Mayor a 60 mmol/L: DX. » RESPUESTA CORRECTA «

75) Hiperparatiroidismo Secundario: $\uparrow$ PTH , $\uparrow$ Ca^{++} , $\downarrow$ PO_4^- .

Causa más frecuente: IRC»RESPUESTA CORRECTA«($\downarrow$ Vit D, $\downarrow$ Ca^{++} , $\uparrow$ PTH, $\uparrow$ Ca^{++} , $\downarrow$ PO_4^-), osteodistrofia renal, etc.

76) Enfermedad de Graves: Ac. Anti receptor TSH.

Es la causa más frecuente de hipertiroidismo

Triada clínica: bocio, exoftalmos, hipertiroidismo.

77) Complicaciones de Enfermedad de Crohn: oclusión, suboclusion, fistulas » PREGUNTA DE CHOISE «, abscesos. Manifestaciones extraintestinales: uveítis anterior aguda.

78) Localización del embarazo ectópico: trompa / ampolla.

79) Mujer embarazada de 16 semanas de gestación con TVP, ¿qué hacer?

Dar Enoxaparina (HBPM) 1 mg/kg/12hs

TVP en embarazo:

- 2 semanas antes del parto: heparina sódica (HNF) EV.
- 1 semana antes del parto: Enoxaparina (HBPM), luego se da Warfarina (no contraindicada durante la lactancia).

80) Sulfato de Magnesio EV en prematuros: es un uteroinhibidor! También se usa para profilaxis de parálisis cerebral.

81) Vómitos en el lactante:

- Biliosos: atresia duodenal, vólvulos.
- No biliosos: hipertrofia del píloro. ERGE (se da a los 6 meses), hiperplasia suprarrenal congénita (se da a los pocos días de vida).

82) Fecha probable de parto: FUM + 10 días – 3 meses.

83) Embarazo: hiperuricemia = predispone HTA en el embarazo!!! Es un predictor de preeclampsia.

84) Variedad de posición: se puede determinar con el Tacto Vaginal.

85) Historia clínica: ver definición de consentimiento informado.

86) Autonomía: ver definición de consentimiento informado.

87) Solicitar HC: ver definición de consentimiento informado.

88) ¿Cuál es la fractura que más sangra? **Fractura de Fémur**

89) ¿Que favorece el acercamiento de la madre con el recién nacido en la 1^{er} hora? El apego.

90) Diagnostico de sinusitis: es clínico!

91) Mola hidatiforme:

- Aumento de gonadotrofina coriónica + sangrado con vesículas.
 - En ecografía se observa “ tormenta de nieve”
 - Predispone a la preeclampsia antes de la semana 18.
-

92) Clasificación de Mallampati:

- Grado I: visibilidad de amígdalas, úvula y paladar blando (fauces y pilares)
 - Grado II: visibilidad de porción superior de amígdalas (fauces), úvula y paladar blando.
 - Grado III: visibilidad de base de la úvula y paladar blando. » PREGUNTA DE CHOISE «
 - Grado IV: visibilidad de paladar duro.
-

93) Clasificación de ASA: (riesgo cardiovascular):

Hombre joven con HTA controlada = **ASA II.**

94) Criterios de Framingham:

MAYORES:

- Crepitantes
- Disnea Paroxística Nocturna (DPN)
- Edema Agudo de Pulmón (EAP)
- Cardiomegalia
- R3
- Ingurgitación venosa yugular (IVY)
- Regurgitación hepatoyugular (RHY) » PREGUNTA DE CHOISE «

MENORES:

- Derrame pleural
- Disnea de esfuerzo
- Tos nocturna
- Hepatomegalia
- Taquicardia
- Edema en miembros inferiores

95) Shock en un niño: ¿cuál es el signo más precoz?: relleno capilar mayor a 2 segundos.

Tratamiento del shock hipovolémico: ¿con que empiezo? Con expansores y coloides (Ringer Lactato).

96) Diagnóstico de cardiopatía ventricular hipertrófica: ecocardiograma.

97) Hematuria glomerular: características:

- Hematíes dismórficos » PREGUNTA DE CHOISE «
- Sin coágulos » PREGUNTA DE CHOISE «
- Presencia de cilindros hemáticos
- Color verdoso, negruzco, pardo, uniforme durante la micción.
- Proteinuria.
- Examen de orina con 30 glóbulos rojos por campo con eritrocitos dismórficos: Glomerulopatía.

98) Tumor benigno de pulmón: Hamartoma. (tiene forma de palomita de maíz)

99) Serotipos de HPV predictores de Cáncer: 16-18-31-33-35-41...

100) Causa más frecuente de colecistitis: litiasis

101) Trastornos de ansiedad e hiperactividad: DX: impulsos? Control? Memoria, lenguaje y pensamiento abstracto.

102) Hombre con cálculos biliares sin comorbilidades: ¿cuál es el abordaje quirúrgico? Laparoscopia.

103) Triada clínica de Cáncer de Células Renales: hematuria – dolor – tumor.

104) Diagnóstico de cariotipo de:

- 5: Síndrome de Marfan.
 - 7: Fibrosis quística
 - 13: Síndrome de Patau: labio leporino, microcefalia, anencefalia
 - 18: Síndrome de Edward
 - 21: Síndrome de Down » PREGUNTAS DE CHOISE «
 - 22: Síndrome Di George.
- TIENEN PALADAR HENDIDO**
-

105) Cefalea en racimo en pediatría:

Las opciones del choise eran las siguientes:

- a) Migraña » RESPUESTA CORRECTA «
 - b) Tensional
 - c) Hipertensión Endocraneana
-

106) ¿Cuándo colocar la gamma globulina dentro de las 72 hs del parto?

- Madre RH negativa: coombs indirecta negativa
 - Hijo RH positivo: coombs directa negativa.
- (Está bien explicado en el Botita de obstetricia)
-

107) Como se realiza el diagnostico de un incidentaloma renal: ecografía.

108) Caso clínico de Artritis Reumatoidea y anemia normocítica normocrómica que no responde al tratamiento con Hierro, con aumento de plaquetas y aumento de GB con predominio de eosinófilos.

109) Patología poligénica multifactorial con participación ambiental:

- DBT » RESPUESTA DEL CHOISE «
- Down
- Turner
- Klinefelter

110) Migraña: cual es el aura más frecuente: visual: fotopsias!
